

Respirar Qualidade Diagnóstico e Registo Clínico nas Doenças Respiratórias Crónicas

2.^a Avaliação da Melhoria Contínua da Qualidade

Maio 2026

USF Serra da Lousã

Com base no protocolo inicial de Junho 2025

Identificação do Projeto



Unidade de Saúde Familiar: USF Serra da Lousã

Equipa responsável: Equipa médica da USF

Data de início: Junho 2025

Duração estimada: 6 semanas (intervenção inicial)

Atualização: 2.ª Avaliação (Maio 2026)

Contextualização e Justificação

Análise Interna

Valores abaixo do desejado no
Indicador 380 detetados no início
de 2025.



Foco na Qualidade

O indicador avalia a coerência entre
a terapêutica respiratória e o
diagnóstico registado.



Omissões de Registo

O não cumprimento decorre
frequentemente de omissões de
diagnóstico, apesar da prescrição
justificada.

"Promover uma melhoria ética e sustentável do desempenho, refletindo a realidade assistencial."

Situação Inicial do Indicador 380

Mês Ind	Designação	Resultado	Score	Min. Esperado	Máx. Aceite
202505	FL 380 – Prop. Adultos...	79,652	1.615	81	100
202509	FL 380 – Prop. Adultos...	85,714	2.000	81	100
202601	FL 380 – Prop. Adultos...	86,796	2.000	81	100
202602	FL 380 – Prop. Adultos...	87,478	2.000	81	100
202603	FL 380 – Prop. Adultos...	88,160	2.000	81	100

Nota: Mínimo aceite: 74 | Mínimo esperado: 81 | Máximo esperado/aceite: 100.

Objetivo Principal

"Melhorar, de forma eficiente e sustentada, a taxa de cumprimento do Indicador 380 através da validação clínica e correção adequada do registo de diagnósticos respiratórios nos utentes com prescrição de inaladores."

| Objetivos Secundários

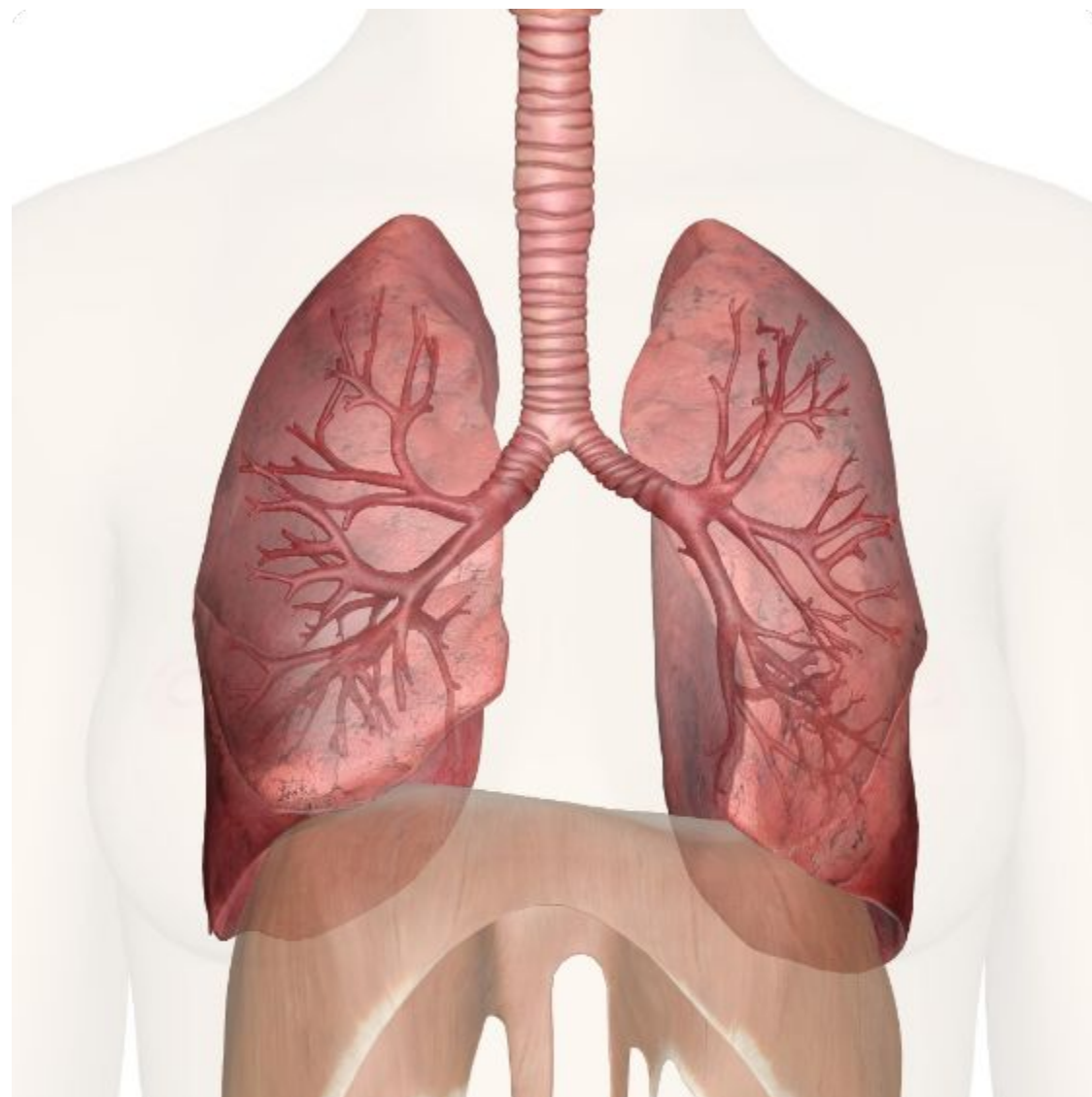
-  Uniformizar critérios de codificação dos problemas respiratórios nos processos clínicos.
-  Sensibilizar a equipa médica para a importância do registo rigoroso e coerente.
-  Promover uma abordagem sistemática e padronizada para validação.
-  Aumentar a sustentabilidade da melhoria a médio e longo prazo.

Definição do Indicador 380

Proporção de adultos com prescrição de medicamentos respiratórios e com diagnóstico de DPOC, asma ou bronquite crônica registado como problema de saúde ativo.

Objetivos do Indicador

- Avaliar coerência Prescrição vs Diagnóstico.
- Indicador contratual relevante.
- Medida de qualidade e fiabilidade do registo clínico.



Denominador (Critérios de Inclusão)

Perfil Utente

- Idade ≥ 18 anos.
- ≥ 1 consulta médica presencial na USF nos últimos 12 meses.

Terapêutica Ativa

Prescrição na USF de pelo menos um medicamento do grupo R03:

- R03AC: Beta2 agonistas curta duração
- R03AK: Combinações c/ corticosteroide
- R03BA: Corticosteroides inalados
- R03BB: Beta2 agonistas longa duração
- R03CC: Antagonistas muscarínicos inalados

* **NOTA:** Apenas prescrições na USF (Exclui hospitalares/externas).

Numerador (Cumpridores)

Consideram-se cumpridores os utentes do denominador que têm registado como **problema de saúde ativo** (campo "Problemas de Saúde"):

R95

DPOC

R96

Asma

R79

Bronquite Crónica

IMPORTANTE: O diagnóstico deve estar ativo. Não é suficiente constar no A do SOAP ou anotações.

Exclusões do Denominador

Exclusão automática se, no **mesmo dia da prescrição**, constar no campo **A do SOAP** um código de condição aguda:

R02 – Dispneia

R03 – Pieira

R04 – Prob. Resp. Outro

R29 – Queixa Resp. Outra

R71 – Tosse convulsa

R78 – Bronquite aguda

R82 – Pleurisia

R83 – Infecção Resp. Outra

R84 – Neoplasia Pulmão

R85/R86/R92 – Neoplasias

R88 – Lesão Resp. Outra

R89 – Malformação

R99 – Doença Resp. Outra

Metodologia: Recolha de Dados

Fonte: MIM@UF

Obtenção sistemática da lista de utentes **não cumpridores** do Indicador 380, estratificada por Médico de Família.



Metodologia: Análise Clínica

Verificação individual de cada caso (Checklist):

Consulta presencial (12 meses)?

Diagnóstico Crônico Ativo?

Prescrição realizada na USF?

Exclusão por SOAP possível?

Metodologia: Intervenções



Correção Registro

Abertura de diagnóstico ativo (R95, R96, R79) em casos clinicamente justificados.



Codificação Aguda

Uso do A do SOAP para casos transitórios, no dia da prescrição.



Sinalização

Agendamento de avaliação presencial para casos com elementos insuficientes.

Metodologia: Uniformização

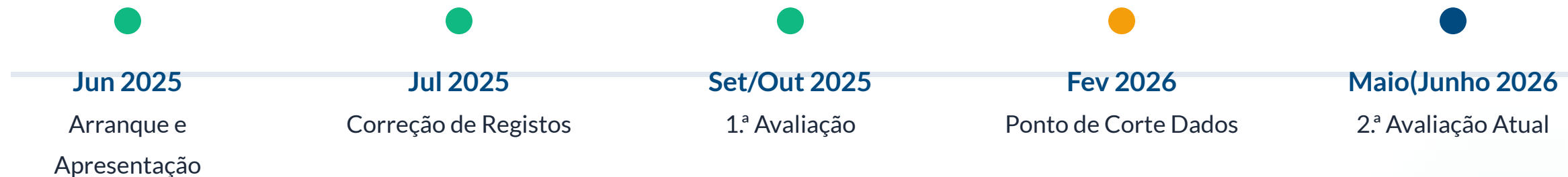
Divulgação Interna

Partilha do protocolo e critérios de codificação com toda a equipa médica da USF Serra da Lousã.

Esclarecimento

Reuniões dedicadas para uniformizar critérios e retirar dúvidas sobre casos específicos.

Timeline da Iniciativa até à 2.ª Avaliação



Critérios de Avaliação

% Registos Corrigidos

Utentes identificados que tiveram correção adequada.

Taxa de Cumprimento

Aumento real no valor do Indicador 380.

% Reavaliações

Utentes convocados para avaliação clínica presencial.

Sustentabilidade

Manutenção da melhoria a médio prazo.

Resultados Esperados

- Aumento eficiente e sustentado da taxa de cumprimento.
- Redução significativa das omissões de diagnóstico.
- Maior coerência entre prescrição e registo clínico.
- Promoção de cultura de codificação rigorosa.
- Valorização do desempenho clínico da USF.

Resultados da 2.ª Avaliação (Fev 2026)

Resultado do Indicador 380:

[inserir valor]

Score: [inserir valor]

Variação face a Março 2025: [inserir valor]

Métricas de Intervenção:

Utentes não cumpridores iniciais: [inserir valor]

Registos corrigidos: [inserir valor]

Reavaliados clinicamente: [inserir valor]

Excluídos (Condição Aguda): [inserir valor]

Situações pendentes: [inserir valor]

Evolução do Indicador 380

80.5

202412

79.4

202501

79.3

202502

79.8

202503

[DADOS
FEV26]

202602

Valores iniciais de 2024/25 vs Projeção para Fevereiro de 2026.

Análise da 2.ª Avaliação

A análise desta 2.ª avaliação deve ser prudente e objetiva:

- Os resultados disponíveis sugerem... **[dados a inserir]**
- A análise deverá considerar a evolução clínica e o impacto da uniformização...
- A sustentabilidade da melhoria deverá ser avaliada através da manutenção dos scores no MIM@UF...

Anexo: Exemplos Práticos

Casos para uniformização e apoio à decisão na aplicação do protocolo do
Indicador 380.

Exemplo 1: Cumpridor

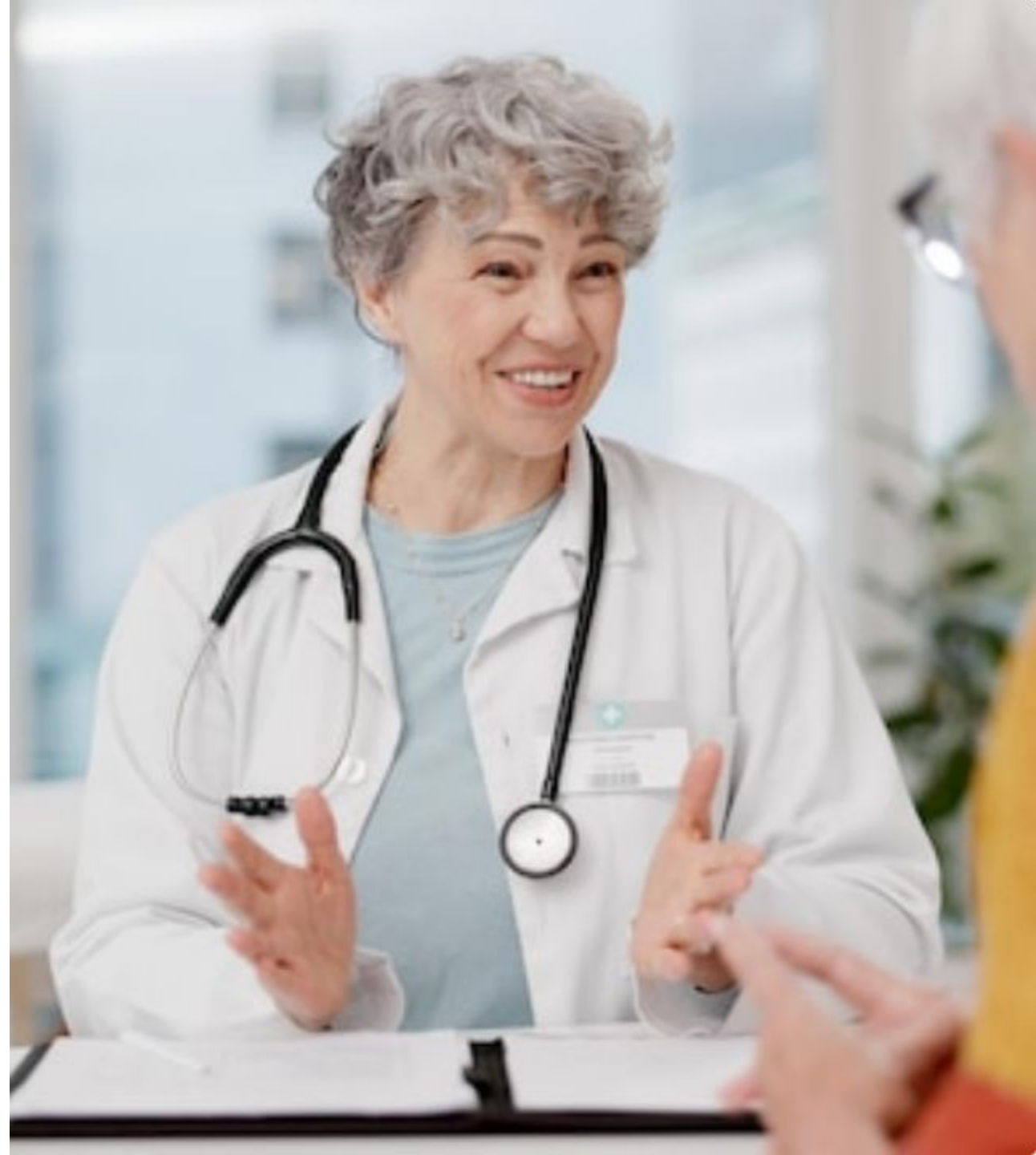
Utente: 74 anos

Prescrição: LAMA + LABA (R03BB + R03CC)

Consulta: Há 5 meses

Diagnóstico Ativo: R95 – DPOC

SITUAÇÃO CORRETA, CUMPRE O INDICADOR.



Exemplo 2: Não Cumpridor

Utente: 55 anos | **Prescrição:** Budesonido (R03BA)

Diagnóstico Ativo: Nenhum

Intervenção sugerida:

- Rever processo (história, exames).
- Confirmar Asma → Abrir R96.
- Se não confirmado → Excluir via SOAP ou convocar consulta.



Exemplo 3: Exclusão via SOAP

Cenário: Utente (40 anos) com gripe e pieira passageira.

Prescrição: Salbutamol 100 mcg.

Registo A do SOAP: R03 – Pieira (no dia da consulta/prescrição).

RESULTADO: Exclusão automática do denominador. Não prejudica o indicador.

Exemplo 4: Erro Comum

Situação: Utente (68 anos) c/ prescrição crónica LAMA+LABA.

Problema: Sem diagnóstico ativo e sem código agudo no SOAP.

PREJUDICA O INDICADOR.

Intervenção: Rever história clínica. Se justificado, abrir diagnóstico ativo R95 ou R96.

Exemplo 5: Diagnóstico Errado

Cenário: Diagnóstico ativo R88 (Infecção Viral) em utente com Budesonido + Formoterol.

NÃO CUMPRE O INDICADOR.

Motivo: R88 é agudo e não entra no numerador.

Intervenção: Corrigir para R96 (Asma) se for patologia crónica.

Exemplo 6: Dúvida Clínica (IC)

Cenário: Utente (80 anos) c/ Insuficiência Cardíaca e pieira aguda. Prescrição de inalador pontual.

Intervenção Recomendada:

- Se pontual: Codificar R03 (Pieira) no A do SOAP.
- Se mantida cronicamente sem causa respiratória: Descontinuar ou reavaliar.

Exemplo 7: Prescrição Hospitalar

Utente: 59 anos

Medicação: LAMA prescrita no Hospital (Sem prescrição na USF).

SEM IMPACTO NO INDICADOR.

Não entra no denominador.

Exemplo 8: Sem Consulta Recente

Cenário: Utente (47 anos) com prescrição, mas última consulta presencial há 14 meses.

NÃO ENTRA NO DENOMINADOR.

Ação: Sinalizar para agendamento de consulta.

Exemplo 9: Bronquite Crónica

Utente: 62 anos | **Prescrição:** LAMA + ICS

Diagnóstico Ativo: R79 – Bronquite crónica

CUMPRE O INDICADOR.

Síntese dos Casos-Tipo

Caso	Estado	Impacto Indicador	Ação Recomendada
Ex 1 / Ex 9	Diagnóstico R95/R96/R79 Ativo	Cumpre	Manutenção
Ex 2 / Ex 4	Prescrição s/ Diagnóstico Ativo	Não Cumpre	Rever registo e abrir diagnóstico
Ex 3 / Ex 6	Prescrição + Código Agudo SOAP	Excluído	Codificação aguda no A do SOAP
Ex 5	Diagnóstico Errado (Ex: R88)	Não Cumpre	Corrigir para código crónico (R96)
Ex 7 / Ex 8	Sem prescrição USF / Sem Consulta	Excluído	Sinalizar para consulta presencial

Aprendizagens Operacionais

Problema Ativo

O campo "Problema de Saúde" é o único que valida o numerador.

SOAP vs Problema

O A do SOAP serve para exclusão (agudo), não para cumprimento crónico.

Critério Temporal

Consultas > 12 meses ou prescrições fora da USF removem utente da lista.

Sustentabilidade da Melhoria

- Manutenção da coerência entre prescrição e registo.
- Redução proativa de omissões de diagnóstico.
- Uniformização de critérios entre a equipa médica.
- Revisão periódica de não cumpridores (MIM@UF).
- Uso dos exemplos práticos como ferramenta de apoio contínuo.

Próximos Passos



Manter monitorização
periódica no MIM@UF.



Reforçar uniformização
da codificação aguda vs
crónica.



Agendar avaliações para
casos sem dados
suficientes.



Preparar nova
reavaliação periódica.



Obrigado!

"Garantir que os registos clínicos refletem a realidade assistencial e promovem a qualidade do cuidado na **USF Serra da Lousã**."